

acompanhamento () consulta
NS 2223169 7036 / 291

JOSE AUGUSTO ALVES FARIA

IDADE: 79 PESO: ALTURA: PROFISSÃO: Aposentado (militar)

SINTOMAS: Esquecimento

QUEIXAS: memória

MEDICAMENTOS: Ritmonorm / plaquil / Denil / disfer / dipter /

Ipomoea / nexium / actonel / plavix / hidroclorotiazida / Relvar

MÉDICO: Dr. Flávia AP Prado (Otorino)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates / caminhada / 2x musculação

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 00h HORA QUE ACORDA: 7-8hs

COCHILO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM (3) X NA SEMANA () NÃO

FUMO (X) SIM () NÃO / MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 20 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 39 slcpap / 42 slcpap SPO2: 73% min

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / arritmia

CIRURGIAS: () NASAL (5) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (5) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

12/06/24 locação

Masc N30 (M)

19/06/24

P = 7 cmH₂O ↓ P = 6 cmH₂O

IAH: 12,9 elh

* dificuldade de

m de uso: 3h 47m

manter a máscara

fuga: 78,4 elh (preencher) e fechar a boca.

Arquitto manter

língua no céu da boca

Natasha

26/06/24

P = 6 cmH₂O

IAH = 10,9 elh

m de uso: 5h 14'

fuga: 62,9 elh

Ainda usando

abertura de boca

Natasha

10/07/24

P = 6,4 cmH₂O

IAH = 7,1 elh

m de uso: 4h 27'

fuga: 62,7 elh

Usando máscara

abertura nasal

Natasha

14/08/24 P= 6,4 cmH₂O

IAH= 6,1 e/h

muro: 3h51'

fuga: 68 l/min

machucou a perna;
está dominando pouco

sugiro dominar mais cedo *Silvia*

09/10/24 P= 6,4 cmH₂O

IAH= 6,3 e/h (A0,6 K:2,4)

fuga: 58 l/min

muro: 4h57 min

* comprou CPAP básico #

Bem adaptado

Silvia

04/12/24

P= 6,4

IAH= 6,2 e/h

fuga: 64 l/min

muro: 4h15 min

Encaminhado Fono → Escape de ar engasgo

1 única boca

sugiro Fono novamente

↓ P: 6,0 cmH₂O

28/01/25 P= 6 cmH₂O

IAH= 5,7 e/h

muro: 4h35'

fuga: 52,4 l/min

Relata estar colocando
microporos e fazendo
fono (1 semana)

Natasha

25/02
25

P= 6 cmH₂O

IAH= 7,7 e/h

muro: 4h50'

fuga: 53,2 l/min

Reforce a importância de
realizar os exercícios da
fono

Natasha

26/05/25

P= 6 cmH₂O

IAH= 5,6 e/h

muro: 5 horas

fuga: 48 l/min

ouvir Fono

Bem Adaptada

Silvia

CÓPIA



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP: 62.658

NOME: José Augusto Alves Faria
EXAME nº: 5544
SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge
DATA 11/12/2023
IDADE: 78 anos

750192

Comentários:

Exame iniciado às 23h00min e concluído às 05h18min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 77 minutos. O tempo total de sono foi de 343,5 minutos (05h43min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,6%. A distribuição do sono mostrou 10,9% de estágio 1, 38,1% de estágio 2, 27,9% de estágio 3 e 23% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 28,5 minutos em vigília, ocorreram 44 microdespertares (índice: 7,7hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 39/hora, sendo 21,3 apneia/hora e 17,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 43,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 89%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 73%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (39/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (43,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 45; máxima: 62 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (77 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (91,6%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (7,7/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (10,9%; normal: 8-10%), 3 (27,9%; normal: 10-12%) e REM (23%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (38,1%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 2 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730